



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : سيده محمد محمدين عبد السيد

المحافظة : القليوبية الحي / المدينة : شبرا الخيمة ثان العنوان : ش محمد عبد الرحيم

رقم البطاقة : 26909282602446 رقم التليفون : 01271020635 تاريخ تسجيل الإستمارة : 21-09-2026

العمر (تاريخ الميلاد) : 28-09-1969 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي التوقيع: (-----)

المقرر بما فيه التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الأبحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني الوظيفة: التوقيع: (-----)

الاسم: د/ندى حسن الوظيفة: التوقيع: (-----)

الاسم: د/نرمين رمضان الوظيفة: التوقيع: (-----)

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة ومدير المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. /----- /د. /----- /د. /-----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----

خطة العلاج : -----

المستشفى : قسم : -----

جهة العلاج : نفقات : -----

ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: سيده محمد محمددين عبد السيد National ID: 26909282602446	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

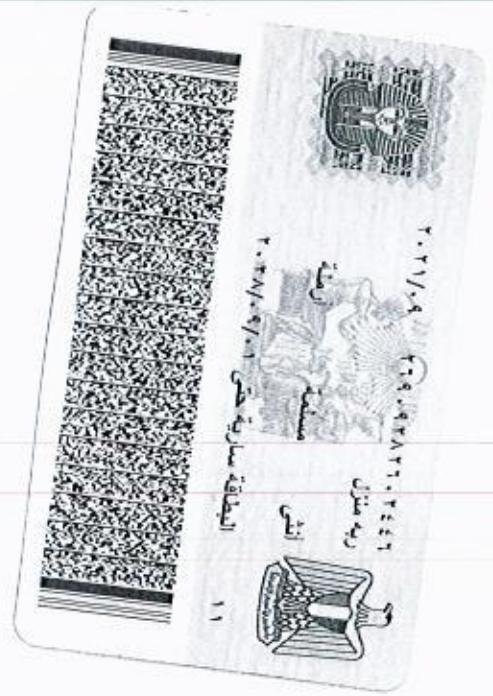
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



٧٨





Patient Name : الأستاذة / سيدة محمد محمدين	Request No. : 13005527
Patient No. : 26909282602446	Request Date : 27/02/2023
Path No. : 592/2023	Verification Date : 06/03/2023
Sex : Female	Financial Category : نفقة الدولة - اورام دار السلام
Age : 41 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Right breast cancer, post NACT.
 Nature Specimen: Right modified radical mastectomy specimen.

Gross Examination:

- * Procedure: Right MRM measured 15x14x4 cm with covering skin ellipse measured 15x7 cm.
- * Tumor extent: A greyish white firm tumor bed site.
- * Size: 6x5 cm.
- * Skin involvement: Nipple & areola were unremarkable grossly.
- * Distance from margins: 0.3 cm away from deep margin (least margin).
- * Lymph nodes number and size: Axilla measured 8x7x2cm entangling 17 L.Ns up to 2.5cm.

Microscopic Examination:

- * Histological type: No residual of tumour tissue in previously diagnosed carcinoma.
- * Ductal carcinoma in situ: No.
- * Lymphovascular emboli: No.
- * Perineural invasion: No.
- * Skin involvement: free nipple and areola.
- * Lymph node involvement: Negative (0/17).
- * Resection Margins: Free deep margin.
- * Histologic response to therapy: Complete pathological response.

Diagnosis:

- Right breast cancer post NACT, MRM specimen:
- * No residual of tumour tissue in previously diagnosed carcinoma.
- * No Ductal carcinoma in situ.
- * Free nipple and areola.
- No lymph node involvement (0/17).

Verified by :

DR.Menna Nabil

Printing Date : 08/03/2023 10:26:56

Page 1 of 2

Printing By : marwa mohamed youss

Patient Name	: الأستاذة / سيدة محمد محمدين	Request No.	: 13005527
Patient No.	: 26909282602446	Request Date	: 27/02/2023
Path No.	: 592/2023	Verification Date	: 06/03/2023
Sex	: Female	Financial Category	: أورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 41 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

- * Free deep margin.
- * Complete pathological response.
- * Stage: ypT0 , ypN0.

Signature
Prof. Dr. Lubna Omar.

Verified by :
DR.Menna Nabil

Printing Date : 29/03/2023 11:01:43

Page 2 of 2

Printing By : .marwa mohamed youss



Patient Name: Sayeda Mohamed Mohamadain Abdel Sayed	Date : 06/06/2024
Exam : MRI BRAIN	Age : 54 Year(s)
Medical ID: 3161/2022	Pat. ID: 15321

MRI EXAMINATION OF THE BRAIN

MRI TECHNIQUE:

- Sagittal T2WI
- Axial T1, T2 and FLAIR WIs
- Coronal T1WI

MRI FINDINGS:

- Prominent extra-axial CSF spaces.
- Normal size and configuration of the ventricular system.
- Normal size and parenchymal signal intensity pattern of the cerebral hemispheres.
- No shift of the midline structures.
- No intra or extra axial S.O.Ls.
- No extra-axial collections.
- Normal appearance of the cerebellum, brain stem and cranio-cervical junction.

OPINION:

- Prominent extra-axial CSF spaces.
- Otherwise, essentially normal MRI exam of the brain.
-

Dr. Amr Farouk, M.D.



Patient Name: Sayeda Mohamed Mohamadain Abdel Sayed	Date : 19/07/2022
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 52 Year(s)
Medical ID: 1319	Pat. ID: 15321

**DIGITAL BILATERAL SOFT TISSUE MAMMOGRAPHY AND
COMPLEMENTARY ULTRASOUND**

Indication:

Right breast palpable mass

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral 3D MLO DBT (Digital Breast tomosynthesis)
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- ACR b Scattered fibroglandular parenchyma
- Right Breast:
 - Partially obscured high density irregular mass is seen in the right retro-areola region with overlying malignant microcalcifications extending into both lower outer and lower inner quadrants covering an area measures about 8x8cm. It is seen by U/S at 9-7 o'clock showing intraductal extension reaching the nipple and causing its deviation.
 - Indeterminate likely reactive enlarged level I axillary LN seen in the axillary tail.
 - No pathological enlarged infra or supraclavicular lymph nodes.
- left Breast:
 - No suspicious micro calcifications or architectural distortion detected.
 - Complementary ultrasound no cystic or solid mass lesions.
 - Normal skin thickness, and nipple-areola complex with average caliber of the retro-areolar central ducts.
 - Nonspecific axillary and IMLNs

Opinion:

- Right breast locally advance multicentric malignant mass with ipsilateral likely reactive axillary lymph-nodes (BIRADS 5) for histopathological examination .
- Normal sonomammography of left breast (BIRADS 1)

Best regards,

Dr Amira H Radwan MD



Patient Name: Sayeda Mohamed Mohamadain Abdel-Sayed	Date : 18/02/2023
Exam : C.T CHEST	Age : 53 Year(s)
Medical ID:	Pat. ID: 15321

NON-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST: -

**Reported case of mesothelioma , Compered with last CT
dated on 16.8.2022**

Findings:

- Still noted bilateral pulmonary pleural based soft tissue density masses with internal calcifications are noted. The largest is seen in the right upper lobe anterior segment measuring about 5.5 x 1.9 cm.
- No sizable hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Bilateral fibroelastoma dorsi.

Opinion :

Reported acse of mesothelioma running a rather stationary course.

Dr: A.Haider

Signature Prof. Menna Talla Hanafy

20/02/2023 04:18 م